

QCM Adénopathies Résidanat 2025

1. Quelles sont les aires de palpation des adénopathies :

- A. Aires épitrochléennes
- B. Aires trochantériennes
- C. Aires palmaires
- D. Aires axillaires
- E. Aires pré-tragiennes

Réponse :

2. Un ganglion est considéré comme pathologique à partir de

- A. 1cm
- B. 2cm
- C. 3cm
- D. 2, 5cm
- E. 0, 5cm

Réponse :

3. Une adénopathie correspond à une :

- A. Augmentation du volume d'un ganglion
- B. Augmentation de la taille d'un ganglion de plus de 1cm quel que soit son siège
- C. Hypertrophie sous cutanée d'une masse graisseuse
- D. Excroissance osseuse palpable sous la peau
- E. Hypertrophie du lobe droit de la glande thyroïde

Réponse :

4. A propos du diagnostic positif d'une adénopathie superficielle :

- A. Est souvent clinique
- B. Nécessite parfois un bilan radiologique
- C. Nécessite une radiographie thoracique
- D. Nécessite une échographie abdominale
- E. Nécessite la pratique d'un PET scanner

Réponse :

5. A propos de l'examen clinique des aires ganglionnaires :

- A. Il est indispensable d'examiner toutes les aires ganglionnaires
- B. En présence d'ADP superficielles la recherche d'hépatosplénomégalie est indispensable
- C. L'examen des gg inguinaux se fait chez un patient debout
- D. En présence d'ADP il faut toujours compléter par une biopsie ganglionnaire
- E. La présence d'ADP axillaires nécessite un examen ORL complet

Réponse :

6. Parmi les caractéristiques suivantes quelles sont celles nécessaires à l'orientation clinique :

- A. La taille
- B. La consistance
- C. L'adhérence aux plans profonds
- D. La présence des signes inflammatoires locaux
- E. La sensibilité

Réponse :

7. Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie inguinale :

- A. Une hernie inguinale
- B. Hydrosadénite
- C. Un testicule ectopique
- D. Un anévrysme vasculaire
- E. Digitations musculaires du grand dentelé

Réponse :

8. Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie axillaire :

- A. Un lipome
- B. Une tuméfaction costale
- C. Un kyste du cordon
- D. Un neurinome
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

Réponse :

9. Parmi les diagnostics différentiels d'une adénopathie cervicale :

- A. Une tumeur parotidienne
- B. Une tuméfaction costale
- C. Un kyste du tractus thyroïdienne
- D. Un kyste du cordon
- E. Une grande corne de l'os hyoïde

Réponse :

10. En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Taille > 4cm
- B. Consistance ferme
- C. Signes inflammatoires locaux
- D. Adhérence au plan profond
- E. Modifications rapides du volume

Réponse :

11. En faveur du caractère malin d'une adénopathie :

- A. Masse ganglionnaire compressive
- B. Consistance molle
- C. Caractère douloureux
- D. Adhérence au plan profond et superficiel
- E. Limites floues

Réponse :

12. Parmi les localisations des adénopathies suivantes, laquelle traduit toujours une pathologie néoplasique :

- A. Inguinale
- B. Axillaires
- C. Sous mentonnières
- D. Sus claviculaire gauche
- E. Jugulo-carotidiennes

Réponse :

13. Deux localisations ganglionnaires sont considérées pathologiques quelle que soit la taille :

- A. Epitrochléens
- B. Sus claviculaire
- C. Inguinaux
- D. Axillaires
- E. Rétro-auriculaires

Réponse :

14. Devant une adénopathie localisée les examens.

- A. De façon systématique
- B. En l'absence d'étiologie au terme de l'examen clinique
- C. Devant la présence de signes généraux
- D. En cas d'adénopathie suspecte de malignité
- E. Devant l'altération de l'état général

Réponse :

15. Devant une adénopathie localisée la ponction ganglionnaire :

- A. Permet de retenir le diagnostic de lymphome
- B. Permet l'étude cytologique d'une adénopathie
- C. A un intérêt diagnostique dans les adénites à pyogènes
- D. Nécessite une anesthésie générale
- E. Peut remplacer la biopsie dans les pathologies tumorale

Réponse :

16. Parmi les localisations des adénopathies suivantes, laquelle traduit toujours une pathologie néoplasique :

- A. Inguinale
- B. Axillaires
- C. Sous mentonnières
- D. Sus claviculaire gauche
- E. Jugulo-carotidiennes

Réponse :

17. En cas de poly adénopathies superficielles, quels sont les examens à demander en première intention :

- A. Un hémogramme
- B. Dosage de la CRP et de la vitesse de sédimentation
- C. Une biopsie ganglionnaire
- D. Une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne
- E. Une sérologie HIV

Réponse :

18. Parmi les situations suivantes, lesquelles imposent une biopsie ganglionnaire :

- A. Adénopathies inguinales fistulisées
- B. Cytoponction non concluante
- C. Suspicion de leucémie aigue
- D. Suspicion d'une adénite
- E. Adénopathie isolée

Réponse :

19. L'adénopathie sous-claviculaire droite est liée à une pathologie :

- A. Cervicale
- B. Sus diaphragmatique
- C. Sous diaphragmatique
- D. Du membre supérieur droit
- E. Mammaire droite

Réponse :

20. L'adénopathie sus-claviculaire gauche est liée à une pathologie :

- A. Broncho-pulmonaire
- B. Digestive
- C. Rénale
- D. Testiculaire
- E. Pelvienne

Réponse :

21. Devant une mono adénopathie cervicale, vous évoquer le diagnostic de tuberculose ganglionnaire devant :

- A. Altération de l'état général et sueurs nocturne
- B. Autres localisations extra-ganglionnaires
- C. Des granulomes à l'histologie avec nécrose caséuse
- D. Leucopénie
- E. Contact avec les animaux

Réponse :

22. La ponction d'une adénopathie cervicale haute a mis en évidence des cellules de Reed Sternberg. Quel examen complémentaire doit-on pratiquer en priorité:

- A. Une biopsie médullaire
- B. Un myélogramme
- C. Une TDM thoraco-abdomino-pelvienne
- D. Un examen ORL
- E. Une biopsie ganglionnaire

Réponse :

23. Concernant la biopsie ganglionnaire, quelles sont les propositions justes :

- A. D'exérèse complète de l'adénopathie constitue l'examen de choix
- B. La biopsie radioguidée de l'adénopathie constitue l'examen de choix d'une adénopathie superficielle
- C. Elle permet la recherche de BAAR dans le tissu ganglionnaire par PCR.
- D. Le ganglion retiré doit être fixé dans le liquide de bouin
- E. Elle permet une étude immunohistochimique du tissu ganglionnaire

Réponse :

24. Quelles sont parmi les propositions suivantes les indications de réalisation de la biopsie ganglionnaire :

- A. Adénopathies inguinales satellites d'un chancre syphilitique
- B. Cytoponction non concluante
- C. Suspicion de leucémie aigue
- D. Suspicion d'une adénite
- E. Adénopathie isolée

Réponse :

25. Une adénopathie sus claviculaire droite peut être associée à:

- A. Tumeur rénale
- B. Cancer du poumon
- C. Lymphome médiastinale
- D. Thymome
- E. Tumeur testiculaire

Réponse :

26. Une adénopathie à Pyogène est :

- A. Principalement dû à des bacilles gram négatif
- B. Associé des signes inflammatoires loco-régionales
- C. Une porte d'entrée est souvent associée
- D. La ponction ganglionnaire est utile pour le diagnostic microbiologique
- E. Son traitement comporte toujours un drainage chirurgical

Réponse :

27. La maladie des griffes du chat est :

- A. Une pathologie d'inoculation
- B. Associé à une griffure ou morsure de chat
- C. Principalement lié à une CGP
- D. Caractérisée par des adénopathies aiguës
- E. Son traitement repose sur une antibiothérapie type Azithromycine

Réponse :

28. A propos de la maladie des griffes du chat :

- A. La période d'incubation est de 2 mois
- B. Les adénopathies sont d'allure inflammatoire
- C. Un état subfébrile est souvent associé
- D. Le diagnostic est confirmé par PCR mettant en évidence *Bartonella henselae*
- E. La biopsie exérèse de l'adénopathie met en évidence une lymphadénite nodulaire abcédée

Réponse :

29. Une adénopathie d'inoculation peut se voir en cas de :

- A. La maladie des griffes du chat
- B. Morsure de chien (Pasteurellose)
- C. La tularémie
- D. La Rickettsiose
- F. Infection à Staphylocoque

Réponse :

30. Les adénopathies médiastinales sont fréquentes dans :

- A. La maladie des griffes du chat
- A. Le lymphome de Hodgkin
- B. La tuberculose
- C. Le lymphome non Hodgkinien
- D. E La leucémie aigue

Réponse :

31. Les éléments suivants sont en faveur de l'origine tuberculeuse des adénopathies:

- A. D'allure très inflammatoire
- B. Le plus souvent cervicales
- C. Le plus souvent bilatérales
- D. Le plus souvent volumineuses palas
- E. Ces adénopathies évoluent toujours vers une fistulisation cutanée

Réponse :

32. En faveur de diagnostic de mononucléose infectieuse chez un enfant ayant des adénopathies multiples :

- A Les adénopathies sont souvent cervicales
- B Associé à une angine pseudomembraneuse
- C. Présence d'une splénomégalie très volumineuse
- D. Une hyperleucocytose à prédominance PNN
- E. Une hyperlymphocytose

Réponse :

33. Une poly adénopathie peut se voir en cas des infections virales suivantes :

- A. Primo infection par le VIH
- B. EBV
- C. Infection par le CMV
- D. Tuberculose
- E. Leishmaniose viscérale

Réponse :

34. Le Syphilis primaire est :

- A. Une maladie sexuellement transmise
- B. Due à l'agent bactérien *Treponema pallidum*
- C. Associé à des adénopathies multiples, inguinales le plus souvent volumineuses, inflammatoires et douloureuses
- D. Associé à un chancre syphilitique
- E. Le diagnostic est sérologique

Réponse :

Dans les maladies sexuellement transmissibles suivantes les adénopathies sont caractérisées par :

- A. ADP inguinale unique volumineuse non inflammatoire Indolore dans la syphilis
- B. ADP inguinale unique volumineuse inflammatoire douloureuse dans la syphilis (
- C. ADP inguinales inflammatoires et d'ulcérations multiples dans le chancre mou
- D. D. Evoluant vers une fistulisation cutanée dans la maladie de Nicolas Favre ou lymphogranulomatose vénérienne
- E. ADP le plus souvent unilatérale, non inflammatoire et non douloureuse, dans la maladie de Nicolas Favre

Réponse :

35. En plus d'une poly adénopathie, la brucellose associe :

- A. Un Typhos
- B. Une fièvre ondulante suduro-algique
- C. Une splénomégalie modérée
- D. Une leucopénie
- E. Une sérologie de Widal positive

Réponse :

36. Parmi les pathologies suivantes, le(les) quelle(s) pourrait(ent) être évoquées devant des adénopathies cervicales et un syndrome mononucléosique :

- A. Mononucléose infectieuse
- B. Maladie de Hodgkin
- C. Toxoplasmose acquise
- D. Maladie de Griffe de chat
- E. Infection à cytomégalovirus

Réponse :

37. La présence des adénopathies axillaires unilatérales gauches peut évoquer un(e):

- A. Carcinome mammaire gauche
- B. Maladie de Griffe de chat
- C. Mononucléose infectieuse
- D. Cancer testiculaire
- E. Syphilis primaire

Réponse :

38. Une adénopathie localisée peut évoquer :

- A. Leucémie lymphoïde chronique
- B. Tuberculose ganglionnaire
- C. Infection de voisinage
- D. Maladie de Griffes du chat
- E. Mononucléose infectieuse

Réponse :

39. Les diagnostics à évoquer chez un patient se présentant avec une poly adénopathie axillaire et inguinale bilatérale :

- A. Métastase d'un cancer digestif
- B. Métastase d'un cancer de la prostate
- C. Infection par le VIH
- D. Lymphome de Hodgkin
- E. Connectivite

Réponse :

40. Devant une adénopathie cervicale isolée, vous évoquez le diagnostic de tuberculose ganglionnaire devant la présence de :

- A. Autres localisations extra ganglionnaires
- B. Signes d'imprégnation tuberculeuses
- C. Présence de granulome sans nécrose caséeuse à l'histologie
- D. Fistulisation
- E. Altération de l'état général

Réponse :

41. Une adénopathie à Pyogène est :
- A. Principalement dû à des bacilles gram négatif
 - B. Associé des signes inflammatoires loco-régionales
 - C. Une porte d'entrée est souvent associée
 - D. La ponction ganglionnaire est utile pour le diagnostic microbiologique
 - E. Son traitement comporte toujours un drainage chirurgical

Réponse :

42. Une adénopathie d'inoculation peut se voir en cas de :
- A. La maladie des griffes du chat
 - B. B- Morsure de chien (Pasteurellose)
 - C. La Tularémie
 - D. La Rickettsiose
 - E. D'infection à staphylocoque

Réponse :

43. L'association splénomégalie, adénopathies cervicales peut être observée dans :
- A. La Leucémie myéloïde chronique (LMC)
 - B. L'aplasie médullaire
 - C. La leucémie lymphoïde chronique LLC
 - D. La leucémie aigue
 - E. La maladie de Minkowski chauffard

Réponse :

44. Un homme de 70 an présent des adénopathies multiples et diffuses avec à la NFS une hyper lymphocytose à 68000 le diagnostic à retenir est :
- A. LMC
 - B. LLC
 - C. Métastase
 - D. Myélome Multiple
 - E. LH

Réponse :

45. Quand une poly adénopathie disséminée est inexpliquée après l'évaluation initiale :
- A. Une antibiothérapie empirique est souvent utile.
 - B. Il est indiqué de surveiller le malade de 3-4 semaine si l'examen clinique et physique ne suggèrent pas une cause néoplasique
 - C. On doit demander une NFS et une radio Thorax et s'ils sont non contributifs, on demande des sérologies virales et un bilan immunologique
 - D. Les ganglions inguinaux sont les ganglions préférés pour la biopsie
 - E. Un traitement antituberculeux d'épreuve est à recommandé

Réponse :

46. Une femme de 40 ans, sans antécédents particuliers, vient consulter pour la découverte fortuite d'une tuméfaction cervicale sous-digastrique de 2x2cm, isolée, ferme non inflammatoire évoluant depuis deux mois, sans aucun caractère infectieux. L'examen clinique de la cavité buccale, du pharynx et du larynx est normal. Le diagnostic évoqué peut-être :
- A. Un kyste congénital de type « amygdaloïde »
 - B. Une thyroïde ectopique
 - C. Une métastase ganglionnaire d'un cancer des voies aérodigestives supérieur
 - D. Une adénopathie d'une hémopathie
 - E. Un kyste du tractus thyroïdienne

Réponse :

47. Un enfant de 3ans présente quelques heures après une griffure de chat, à ce niveau, un œdème rouge chaud et douloureux s'accompagnant d'une traînée de lymphangite. Vous soupçonnez une complication infectieuse. Quel germe est a priori en cause :

- A. Francisellatularensis
- B. Pasteurella multocida
- C. Clostridium tetani
- D. Staphylococcus aureus
- E. Rothiadenocariosa

Réponse :

48. Une adénopathie Inguinale dure et fixe peut-être en rapport avec une tumeur :

- A. De la vulve
- B. Du canal anal
- C. De l'ovaire
- D. De la prostate
- E. Du col de l'utérus.

Réponse :

49. Le Syphilis primaire est :

- A. Une maladie sexuellement transmise
- B. Due à l'agent bactérien Treponema pallidum
- C. Associé à une adénopathie inguinale unique, volumineuse. Non inflammatoire et indolore
- D. Associé à un chancre syphilitique
- E. Secondaire à une morsure par le chat

Réponse :

50. Les éléments suivants sont en faveur de L'origine tuberculeuse des adénopathies:

- A Associés à une altération de l'état général
- B. D'allure très inflammatoire
- C. Le plus souvent cervicales
- D. D. Le plus souvent bilatérales et volumineuses
- E. E. Ces adénopathies évoluent toujours vers une fistulisation cutanée

Réponse :

CAS CLINIQUE 1 : Patient âgé de 50 ans consulte pour tuméfaction cervicale évoluant depuis 3 mois. Il rapporte la notion de sueurs nocturnes et un amaigrissement de 4 kg. À l'examen, il était apyrétique, avec présence d'une adénopathie jugulo carotidienne haute de 3cm, fixe, ferme et peu mobile. Le reste de l'examen ORL était sans anomalies.

51. Les bilans à demander en 1ère intention sont :

- A. Une IDR à la tuberculine
- B. LDH
- C. Bilan inflammatoire
- D. Une calcémie
- E. Les anticorps antinucléaires

Réponse :

52. Les autres examens complémentaires à réaliser sont :

- A. Une échographie cervicale
- B. Biopsie du cavum
- C. Une radiographie du thorax
- D. Une Biopsie ganglionnaire
- E. Une TDM thoraco abdomino pelvienne

Réponse :

53. Un examen cytologique réalisé pour ce patient a objectivé un granulome giganto cellulaire centré par de la nécrose caséeuse. Le diagnostic à retenir est:

- A. Une sarcoïdose
- B. Un lymphome hodgkinien
- C. Une tuberculose ganglionnaire
- D. Une pathologie d'inoculation
- E. Un cancer du cavum

Réponse :

CAS CLINIQUE 2 Patient de 42 ans, fumeur à raison de 15 paquet/année, consulte pour une masse cervicale haute droite, augmentant progressivement de taille depuis 2 mois.

54. Votre démarche diagnostique doit comporter :

- A. Un interrogatoire minutieux
- B. Une endoscopie nasale
- C. Une fibroscopie bronchique
- D. Une IRM cervicale
- E. Une laryngoscopie indirecte

Réponse :

Il n'avait pas de notion de contact tuberculeux. L'examen clinique, retrouve à la palpation une adénopathie cervicale sous-angulo-maxillaire de 6,5 cm de grand axe, dure, indolore, fixée par rapport aux plans profond et superficiel. Le reste de l'examen physique était sans anomalies.

55. Le(s) signe(s) en faveur de l'origine maligne de l'adénopathie sont :

- A. Le caractère induré
- B. La fixité aux plans profond et superficiel
- C. Le caractère indolore
- D. L'âge du patient
- E. L'évolution rapide

Réponse :

56. Les examens complémentaires à demander de 1ère intention sont :

- A. Biopsie écho-guidée de l'adénopathie cervicale
- B. Une échographie cervicale
- C. Une IDR à la tuberculine
- D. Une cytoponction ganglionnaire
- E. Une sérologie syphilis

Réponse :

57. Le bilan réalisé a conclu à une adénopathie métastatique sans primitif, votre conduite ultérieure doit comporter :

- A. Une TDM thoraco abdomino pelvienne
- B. Une pan endoscopie
- C. Une biopsie systématique du cavum
- D. Une sérologie EBV
- E. Une scintigraphie osseuse

Réponse :

